EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	73965
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-11-12 11:25:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA INES SANDOVAL CONSTANZO			RUN	: 3.660.578-2
F.Nac	: 24-10-2019	Edad	: 4 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 11-11-2023	Fecha Egreso	: 2023-11-12 11:25:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Neumonia aspirativa en tratamiento
2) ITU en tratamiento
3) ERC
4) Limitacion severa ABVD
5) DM2 IR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec de limitacion severa ABVD, ERC, DM2 IR; consulta en SU el dia 11/11 por cuadro de CEG, hipoalimentacion.
Examenes de lab al ingreso se videncia glicemia 96, albumina 2,9; crea 2,6; FA 131; bili tot 0,7; lactato 0,7; PCR 10; uremia 129; BUN 60; Na/K/Cl 136/3.5/105; Hb/Hcto 7.8/22.7; Gb 3,4; plaq 152000; orina de aspecto turbio, bacterias abundante cantidad. TAC de torax impresiona con leves fenomenos aspirativos del lobulo inferior derecho, derrame pleural bilateral, ateromatosis aortocoronaria.
Se decide ingreso para tratamiento ATB
Durante su estadia estable, se inicia terapia ATB de amplio espesctro, con buena evolucion clinica
Paciente HDN estable, con P/A con tendencia a la hipertension durante estadia, con buena tolerancia a la alimentacion VO, diuresis 400 cc por foley en las ultimas 12 hrs, sin episodios de nauseas y/o vomitos, sin requeirmiento de O2 suplementario desde su ingreso, sin episodios de agitacion psicomotora

Ex de lab control -> glicemia 137; crea 2,3 (basal 2,2), PCR 21,6; uremia 127; Na/K/Cl 136/3.8/104; Hb/Hcto 8/23; Gb 5,2; plaq 155000; segment 84%;

Ex fisico -> Vigil, parcialmente orientada en tiempo y espacio, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades se aprecia AVO en EII en comparativa a EID, fovea (+), sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 1 hospitalizado, dia 1 de terapia ATB, en condiciones de continuar con hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Se procedera a inicio de terapia antiHTA para control de P/A
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Se modificata terapia ATB para cumplir requerimientos de HODOm, con parametros inflamatorios bajos, se solicitara control de examenes dentro de 48 hrs, se completara esquema ATB por 7 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Regimen papilla diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 7 dias
4. Metronidazol 500 mg c/8 hrs VO por 7 dias
5. Losartan 50 mg, medio comp c/12 hrs VO por 7 dias
6. Carbamazepina 200 mg al dia VO
7. Sertralina 50 mg al dia VO
8. Omeprazol 20 mg al dia VO
9. Paracetamol 500 mg, 2 comp al dia VO por 3 dias
10. Sulfato de fierro un comp al dia VO
11. Furosemida 40 mg al dia VO
12. Insulina NPH 6 Ui AM SC
13. Dejo orden de ecotomografia de partes blandas para estudio de AVO en EII
14. Examenes de control dentro de 48 hrs
15. KNT respiratoria una vez al dia

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO